

Infecção Congênita por Citomegalovírus

Vamos falar agora sobre uma das infecções congênitas mais cobradas nas provas de residência: o **citomegalovírus**, o famoso **CMV**. E não é à toa que ele aparece tanto nas questões, afinal, estamos falando da **infecção congênita mais comum do mundo**. Então, se você dominar esse tema, vai estar preparado para gabaritar qualquer questão que aparecer.

Primeiramente, é fundamental entender que a **maioria dos casos de CMV congênito é assintomática**. Isso mesmo, a maior parte dos bebês infectados não vai apresentar nenhuma manifestação clínica ao nascimento. Porém, quando o vírus resolve dar as caras, ele deixa algumas pistas bem características que você precisa memorizar.

O achado clássico que deve acender o alerta para CMV é a **surdez neurossensorial**. Existe até aquele mnemônico que muita gente aprende na faculdade: "**CêMêVê**, mas não me ouve". Então, sempre que a questão trazer um recém-nascido com comprometimento auditivo neurossensorial, pense imediatamente em citomegalovírus. Vale lembrar que essa surdez pode ser **progressiva**, ou seja, o bebê pode nascer com audição normal e desenvolver o déficit ao longo dos primeiros anos de vida. Por isso o acompanhamento audiológico precisa ser prolongado.

Outro achado importantíssimo são as **calcificações periventriculares**. Aqui mora uma pegadinha clássica de prova que você não pode errar. Preste atenção: no CMV, as calcificações são **periventriculares**, ou seja, ficam ao redor dos ventrículos cerebrais. Já na **toxoplasmose**, as calcificações são **difusas**, espalhadas por todo o parênquima cerebral. Essa diferenciação é cobrada com frequência e pode ser o detalhe que separa você dos demais candidatos. Uma forma de lembrar é associar o "V" de CMV com "Ventrículo" – calcificações periventriculares.

Além desses achados neurológicos, o bebê com CMV sintomático pode apresentar **microcefalia**, **rash petequial** (aquelas petéquias disseminadas pela pele, refletindo o acometimento hematológico) e **coriorretinite** ao exame de fundo de olho. Também pode haver manifestação hepática com **colestase**, então fique atento se a questão mencionar icterícia com padrão colestático em um contexto de infecção congênita.

Falando agora sobre o **diagnóstico**, o método de escolha é o **PCR** em amostra clínica, preferencialmente na **urina** ou na **saliva**. Aqui tem um detalhe temporal que as bancas adoram cobrar: esse exame precisa ser coletado nas **primeiras três semanas de vida**, ou seja, nos primeiros **21 dias**. Por que esse prazo? Porque após esse período, não conseguimos mais diferenciar se a infecção foi congênita ou adquirida no período pós-natal. Se por algum motivo o PCR não estiver disponível, a detecção de **IgM positivo** no recém-nascido também confirma o diagnóstico, uma vez que o IgM não atravessa a barreira placentária e, portanto, indica produção própria do bebê.

Quanto ao **tratamento**, nem todo bebê com CMV congênito precisa ser tratado. A indicação terapêutica é apenas para os casos **sintomáticos moderados a graves**, e o objetivo principal é a **estabilização clínica** e a **melhora do prognóstico auditivo**. É fundamental iniciar o tratamento até o **primeiro mês de vida** para ter eficácia.

Existem duas opções de drogas antivirais. A primeira é o **Valganciclovir**, que tem a vantagem de ser administrado por **via oral** e o tratamento dura **seis meses**. O problema é que essa medicação **não é padronizada no SUS**, então na prática das maternidades públicas acaba não sendo a primeira escolha. A segunda opção é o **Ganciclovir**, que é **endovenoso** e o tratamento dura **seis semanas**. Essa é a droga mais utilizada no serviço público. Suas desvantagens incluem a necessidade de **acesso venoso prolongado** e o risco de **neutropenia** como efeito colateral, exigindo monitorização hematológica durante o tratamento.

Por fim, o **acompanhamento** desses bebês precisa ser multidisciplinar e prolongado. O seguimento **audiológico** deve ser mantido até a **vida adulta**, por volta dos 19 anos, justamente porque a surdez pode ser progressiva. Se houver lesão ocular, o acompanhamento **oftalmológico** também é necessário. E, claro, todo bebê que teve

acometimento do sistema nervoso central precisa de avaliação do **desenvolvimento neuropsicomotor** ao longo da infância.

GATILHO PARA PROVA

SURDEZ SENSORIAL → pensar em CMV

Calcificações **PERI**ventriculares → CMV

Tratamento:

1ª) Vanciclovir **VO** por **6 meses**

2ª) Ganciclovir **EV** – **6 semanas**.

